

1 wk。俞宝田^[5]用类似方法治疗慢性荨麻疹20例,有效率达90%,与对照组(口服克敏嗪)相似,但脑益嗪的嗜睡和镇静副作用的发生率较低,且多数病人的反应较轻,仍能坚持正常工作,故可作为近期治疗荨麻疹的首选药物。

参考文献

1 杨啸宇,刘俊钦.消炎痛治疗慢性荨麻疹.中华皮肤科杂

志,1988,21(2):102

2 张国钦.氟化喹啉治疗慢性荨麻疹50例.中华皮肤科杂志,1987,20(4):228~229

3 褚国弟.转移因子对142例慢性荨麻疹的疗效观察.临床皮肤科杂志,1989,4:190

4 黄云.脑益嗪治疗慢性荨麻疹的临床观察.药学通报,1987,22(10):622

5 俞宝田.脑益嗪治疗慢性荨麻疹和皮肤划痕症46例分析.北京医学,1989,11(1):63

(1992年1月4日收稿)

环孢素和酮康唑的药物相互作用

杨正鸿 周燕文 (广西医学院附属医院 南宁 530027)

环孢素(Cyclosporine A, CsA)是一强免疫抑制剂,现已广泛用于器官移植的治疗。器官移植病人由于免疫功能低下,易受感染特别是易受真菌感染,常首先考虑加用抗真菌药酮康唑(Ketoconazole, Ket)。国外有关Ket与CsA的药物相互作用已有多篇报道,综述如下:

1 合用后CsA血浓度和血清肌酐值的变化

Ferguson等^[1]报道:肾移植病人当按CsA12mg/(kg·d)的方案口服给药,加服Ket400mg/d,以高效液相法(HPLC法)测得全血谷浓度升高了5倍,尽管减少了CsA剂量。CsA浓度和血清肌酐值仍维持较高水平。停Ket几周后,CsA血液和血清肌酐回至基础值。Shepard等^[2]报道:一肾移植者,当同时口服CsA320mg/d和Ket600mg/d,CsA血液大大升高,同服后的d2、d4,其CsA血液由52ng/ml分别升高到110ng/ml和220ng/ml,同时血清肌酐从基础值的114.9μmol/L增加到168.0μmol/L,203.3μmol/L。停用Ket后7d,并且维持CsA3次/d,病人CsA血液和血清肌酐分别降到了47ng/ml和132.6μmol/L。相似的CsA和Ket相互作用的例子在骨髓移植病人中也有不少报道^[3~5]。

2 合用后CsA剂量的调整

First等^[6]报道:18例肾移植病人,同时口服Ket和CsA,Ket剂量200mg/d,起始CsA剂量8mg/(kg·d),HPLC法测定全血浓度,合用后,

不断地减少CsA剂量以维持CsA有效免疫抑制浓度,避免肾毒性产生,17例合用了7~13mo(平均8.5mo),未加Ket前,平均CsA剂量451mg/d,合并治疗3mo后,CsA剂量减少68~89%,全血平均谷浓度合用前后分别为132ng/ml和127~147ng/ml,血清肌酐和血尿素氮水平前后相似,未发现肝毒性,少数病人合用1a,剂量减少,可以大大地减少移植费用。

另Girardet等^[7]报道:给予病人比常用抗真菌剂量低的Ket(50~100mg/d),服药后2h所得Ket血清峰浓度0.3mg/ml(HPLC法),位在抗多种真菌的最低抑制浓度(MIC)范围之上;经对病人3a以上的追踪表明:合用低剂量的CsA和Ket是有效且安全的。

3 合用对肝毒性、肾毒性影响

Ket本身是一免疫抑制剂,易引起肝损害。肾移植病人本来也表现了肝功能的不足,按理合用会增加肝坏死的风险,但实验证明^[6]:对18例肾移植者进行两药合用的研究中,除一例外,没有发现肝毒性,认为:与Ket有关的肝毒性是一特异体质的药物反应,所以,两药合用肝毒性的相加不一定会发生。CsA引起肾毒性主要表现为血清肌酐值的上升,其机制可能为体内血栓烷A₂(TXA₂)及前列环素(PGI₂)的改变有关,特别是TXA₂的升高。First等^[6]在18例肾移植病人进行的CsA与Ket相互作用研究中无一例发生肾毒性,究其原因,认为与Ket抑

中国医院药学杂志1992年12卷第9期

制 TXA₂ 合成能力有关. Ket 是一血栓烷合成酶抑制剂, 它的使用高度选择性地抑制了 CsA 诱导肾产生 TXA₂, 即酮康唑的使用对 CsA 可能起着肾毒性的保护作用。

4 结语

CsA 与 Ket 在体内具有相互作用, Ket 对 CsA 的作用常于 2~4d 内观察到, 但停用 Ket 后其作用至 3WK 才会消失, 同时必须减少 CsA 剂量, 以避免 CsA 血浓过高而产生肾毒性, 合用后停用 Ket, 则需增加 CsA 剂量, 以维持有效的免疫抑制作用, 避免移植物排斥反应的发生. 两药合用后, 密切监测 CsA 血浓、肾功能、肝功能是很重要的。

参 考 文 献

- 1 Ferguson RM, Sutherland DER, Simmons RL, et al. Ketoconazole, cyclosporin metabolism, and renal transplantation. *Lancet*, 1982, 2: 882~3
- 2 Shepard TH, Canafax DM, Simmons RL, et al. Cyclosporine-ketoconazole: a potentially dangerous drug-drug interaction. *Clin Pharm*, 1986, 5: 468
- 3 GLuckman E, Devergie A, Lokiec F, et al. Nephrotoxicity of cyclosporin in a bone-marrow transplantation. *Lancet*, 1981, 2: 144-5
- 4 Dieperink H, Moller J. Ketoconazole and cyclosporin. *Lancet*, 1982, 2: 1217
- 5 Morgenstern GR, Powles R, Robinson B, et al. Cyclosporin interaction with ketoconazole and melphalan. *Lancet*, 1982, 2: 1342
- 6 First MR, Schroeder TJ, Weiskittel P, et al. Concomitant administration of cyclosporine and ketoconazole in renal transplant recipients. *Lancet*, 1989, 2: 1198-201
- 7 Girardet RE, Melo JC, Fox MS, et al. Concomitant administration of cyclosporine and ketoconazole for three and a half years in one heart transplant recipient. *Transplantation*, 1989, 48(5): 887-90

(1991 年 11 月 26 日收稿)

1993 年征订启事

《中国药理学杂志》(原名药理学通报)为中国药学会主办的、国内外公开发行的综合性药理学学术刊物, 是一本反映我国药理学各科进展和动态的高、中级专业性学术期刊, 以高、中级药学工作者及其他医药卫生人员为读者对象。

本刊内容包括药理学、临床药理学、药理学、药品检验学、药物化学、药品生物化学、中药及天然药物学等。辟有专题笔谈、药品生产、中药及天然药物、药理、药剂、药品质量与检验、药物与临床、药物不良反应、新药评介、综述、药学史、知识介绍、科学管理、问题讨论、科研简讯、文摘与资料、药学信息等 20 多个栏目, 欢迎订阅。现已开始 1993 年征订, 请及早到当地邮局订阅。

本刊国内统一刊号 CN11-2162/R, 邮发代号 2-232, 为 16 开本 64 页, 每期定价 2.2 元。

《药理学学报》由中国药学会主办。国内外公开发行。本刊内容包括药理学、天然药物化学、合成药物化学、药物分析、药剂、生药学与抗生素等方面的研究论文、研究简报、学术动态、综述与述评等。本刊为月刊。每期 80 页。每期定价 3.5 元。国内读者请到当地邮局订阅。也可直接汇款寄本刊编辑部。国内期刊代号: 2-233; 国外读者请向中国图书贸易公司(中国国际书店, 北京 399 信箱)订阅。

《中国医院药理学杂志》系中国药学会主办的、国内外公开发行的专业性学术期刊。旨在交流和推广医院药学的学术成果和实践经验, 提高医院药学工作者的学术水平, 促进我国医院药学事业的发展。本刊栏目设有实验研究、临床药理学、科技交流、经验介绍、中西药制剂、医院制剂质量控制、药剂科的科学与管理改革经验、药理学基础理论、国外见闻、药物不良反应、读者园地等多个栏目。读者对象为医院药学工作者、临床医师、医药院校师生、医药研究单位专业人员、药厂研究人员等。本刊为月刊, 每月 13 日出版, 每期定价 1.80 元。编辑部地址: 武汉市胜利街 177 号, 邮政编码: 430014, 本刊邮发代号 38-50。本刊国内统一刊号 42-1204; ISSN1001-2513。

1993 年征订工作已开始, 请到当地邮局订购。国外订阅请同中国国际图书贸易总公司(中国国际书店)北京 399 信箱联系。